Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)

À RETENIR

- Radiographie : 1 nécrose et condensation (coquille d'œuf) → 2 fragmentation → 3 reconstruction → 4 déformation séquellaire.
- Scintigraphie osseuse : **classification de Conway** (NB), deux voies de revascularisation.
- **Voie A** = reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure : **colonne externe** (activité postéro-latérale) → extension médiale → vascularisation complète (Rx normale ou ↑ interligne).
- **Voie B** = néovascularisation : remplissage de la **base** « en dôme » puis aspect en **champignon** → tête déformée, aplatie, excentrée.
- Stade I (A ou B) = atteinte totale de la tête : hypofixation, Rx normale.

I. Radiographie

Stade	Aspect
1	Nécrose et condensation / coquille d'œuf
2	Fragmentation
3	Reconstruction
4	Déformation séquellaire

II. Scintigraphie osseuse — classification de Conway (NB)

1. Voie A = reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure

Stade	Scintigraphie	Radiographie
IA — atteinte totale de la tête	Hypofixation de la tête fémorale	Normale
IIA — colonne externe	Colonne d'activité postéro-latérale	Condensation épiphysaire
IIIA — extension médiale	Activité étendue à la partie interne de la tête	Kyste ?
IVA — vascularisation complète	Fixation sur toute l'épiphyse	Normale ou ↑ interligne

2. Voie B = néovascularisation par l'artère circonflexe externe

Stade	Scintigraphie	Radiographie
IB — atteinte totale de la tête	Hypofixation de la tête	Normale
IIB — remplissage de la base	Activité centrale débutante de la base de la tête, « en dôme » ou « champignon »	—
IIIB — aspect en champignon	Activité de la base jusqu'à la ½ de la tête	—
IVB — revascularisation complète	Fixation sur toute l'épiphyse	Tête déformée, aplatie et excentrée

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les 4 stades radiographiques de l'OPH.	Nécrose/condensation, fragmentation, reconstruction, déformation séquellaire.
2. Quelle classification scintigraphique est utilisée ?	Classification de Conway.
3. Quel mécanisme définit la voie A ?	Reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure.
4. Aspect scintigraphique du stade IIA ?	Colonne d'activité postéro-latérale (colonne externe).
5. Aspect scintigraphique du stade IIIB ?	Aspect en champignon : activité de la base jusqu'à la moitié de la tête.
6. Aspect radiographique final de la voie B ?	Tête déformée, aplatie et excentrée.